

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Crise d'épilepsie

Conduite à tenir devant crise convulsive chez un résident connu ou non épileptique, avec gradation selon durée et répétition.

Indications

- Crise convulsive brève avec récupération rapide.
- Crises courtes répétées chez résident épileptique connu.
- Application de consignes d'urgence individualisées.

Vérifications préalables

- Noter heure de début et durée de la crise.
- Sécuriser l'environnement, desserrer les vêtements, protéger la tête.
- Ne rien mettre dans la bouche, ne pas contenir les mouvements.
- Vérifier l'existence d'un protocole individuel d'urgence.

Ne pas appliquer ce protocole

- Absence de récupération entre deux crises.
- Crise prolongée > 5 minutes.
- Première crise, traumatisme majeur, grossesse ou contexte inhabituel.
- Détresse respiratoire ou cyanose persistante.

Conduite à tenir

- Pendant la crise : protéger sans contenir.
- Après la crise : position latérale de sécurité et surveillance.
- Si protocole individualisé prescrit : l'appliquer strictement.
- Prévenir IDE/médecin si répétition ou contexte inhabituel.

Surveillance et traçabilité

- Tracer heure début/fin, type de crise, récupération et facteurs déclenchants.
- Noter traitement administré, tolérance et état post-critique.
- Vérifier chute, traumatisme, morsure de langue ou incontinence.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide pour crises courtes répétées ou récupération incomplète.
- Appel 15 si crise > 5 minutes, récurrence sans reprise de conscience, détresse respiratoire ou traumatisme sévère.

Mention de sécurité

Toujours privilégier un protocole d'urgence individualisé. Durée de crise et récupération post-critique doivent être tracées précisément.

Fait à :

Le : / /

Signature :